

Об авторах

К участию в этом коллективном издании я пригласил тех коллег, с кем чувствую наибольшую близость в отношении стиля работы, теоретической и клинической позиции и уважения к человеческим судьбам. Для меня большая честь и радость делить с ними эти страницы, на которых мы излагаем наше понимание психоанализа.

Стефано Болоньини не нуждается в представлении, поскольку он возглавлял Международную психоаналитическую ассоциацию (IPA) и Итальянское психоаналитическое общество (SPI) и остается одним из самых известных итальянских психоаналитиков в мире. Для меня он главная теоретическая и клиническая опора. Его работы об эмпатии и интерпсихическом взаимодействии легли в основу моих размышлений о близости, приведенных в этом сборнике.

Джанни Белья — один из самых мудрых и добрых людей, которых вы можете встретить в своей жизни. Щедрость, с которой он делится рассказом о своем аналитическом путешествии вместе с пациентом Серджио, дарит нам одно из наиболее развернутых клинических опи-

саний модели поля, когда-либо созданных. Он является действительным членом SPI.

Моника Бомба — тонкий исследователь и глубокий клиницист, любознательный и неутомимый. Представленная ею работа демонстрирует, как опыт внимательного психоаналитика может оказать влияние и на клиническую практику в психиатрическом стационаре. Моника — ассоциированный член SPI и научный секретарь Миланского центра психоанализа.

Полина Черкас — единственная неитальянская участница этого сборника. Это жизнерадостная и талантливая молодая девушка, специалист по индивидуальному и групповому анализу. Она выросла и получила образование в Москве, а несколько лет назад эмигрировала в Израиль. Выслушав от нее лично историю работы «аналитика под бомбами» во время недавнего конфликта между Израилем и Ираном, я предложил ей сопроводить ее проникновенное свидетельство моими размышлениями об уязвимости аналитика.

Витторио Гонелла, чуткий детский психотерапевт и мой близкий друг, сочетает в себе способность к глубокому и заботливому слушанию с неподдельной страстью к рок-музыке. Его коллекция дисков поистине необозрима. Из множества его прекрасных текстов, в которых он объединяет рок-музыку и психоанализ, я выбрал для книги тот, который рассказывает об уязвимости такой культовой фигуры, как Джим Моррисон. Витторио состоит в Итальянском обществе психоанализа и психотерапии имени Шандора Ференци.

Элена Морганти, миланский психолог, проходящий обучение в Адлерианской школе психотерапии, на про-

не проявлялась в искаженных и крайних формах, как перенос и контрперенос.

Именно с развитием биперсональных, реляционных, интерсубъективных и полевых парадигм интерес психоаналитиков стал смещаться в сторону способности участников аналитической пары настраиваться друг на друга, чтобы дать место эмоциональным трансформациям, присущим аналитическому процессу.

Мельтцер (Meltzer, 1986) утверждает, что задача психоанализа состоит в том, чтобы трансформировать природу аналитических отношений, изначально договорную, в отношения близости, включающие эмоциональный опыт, который способен стимулировать психический рост посредством длительных усилий по контейнированию и символизации переживаемых эмоций.

Значимые эмоциональные и творческие шаги пациента и аналитика навстречу друг другу — онтологическое измерение психоанализа, по определению Огдена (Ogden, 2019), — требуют от клинициста умения приостанавливаться и поддерживать в живом и действующем состоянии пространство встречи, которое способствует этим шагам и оберегает их, — то есть аналитическую близость.

С клинической точки зрения, понятие близости нельзя считать достигнутым раз и навсегда. Слова «мы достигли близости» звучат как старое доброе «и жили они долго и счастливо» из сказки, которой убаюкивают детей, но они ничего не рассказывают об эмоциональных бурях, собственных любым человеческим отношениям. Как и другие понятия, такие как сеттинг, перенос, эмпатия, близость может быть очень полезным инструментом, если только не пытаться превратить ее в нечто зафиксированное, ове-

щественное. Если же она, напротив, остается динамичным, изменчивым и непреднамеренно приходящим измерением, она может показывать состояние аффективной проницаемости аналитической пары в каждый момент времени.

Близость формирует ту область контакта, которая позволяет нам заставить внутренние струны пациента вибрировать от наших комментариев или интерпретаций. Она представляет собой совместно проживаемое состояние относительной внутренней свободы, более проницаемое для предсознательных и бессознательных коммуникаций, которые делают возможными процессы субъективации, сновидения⁵ и переваривания переработанных травм.

И наоборот, мы сразу же понимаем, что очень далеки от этого счастливого, а потому весьма шаткого измерения, когда в ответ на наши искренние и страстные интервенции слышим: «И что?»

Если другой не знает, куда ему девать наш вклад, нам ничего не остается, как сделать вывод: мы далеки от того, чтобы дать ему нечто действительно ценное. «Нечто меньшее, чем интерпретация», — сказал бы Стерн и его коллеги (Stern, et al., 1998). Иногда, как в случае Франчески, который я привел в самом начале, пациент находится вовсе не там, где мы представляли: он функционирует на более регрессивном уровне или защищается от вторжений преследователя; в других случаях именно аналитику трудно задержаться на пороге на то время, которое необходимо,

5 Мы используем слова «сновидеть», «сно-видение» и «сон»/«сновидение» в зависимости от контекста. Сно-видение передает идею Бюна о сновидческой активности как базовой психической функции, непрерывно действующей как ночью (сновидения), так и днем (мысли, эмоции). — *Прим. ред.*

и организует устойчивые и глубоко витальные состояния селф.

Мы заново открываем и воссоздаем условия, эквивалентные этому постепенному переходу от отношений *внутри матери* к *вместе с матерью*, на многих этапах терапевтического процесса, однако ключевое значение этих этапов не всегда получает должное признание как в клиническом, так и в теоретическом контексте.

На самом деле термины *симбиоз* и *слияние* (Mahler, 1968, 1972) до сих пор упоминаются в психоаналитической литературе преимущественно в патологическом ключе, главным образом в связи со спутанными, фиксирующими, паразитическими и более или менее скрытыми манипулятивными проявлениями; они не рассматриваются в физиологическом смысле (Pallier, 1990; Bolognini, 2002, 2008a; Fonda, 2000; Bonfiglio, 2018), то есть в отношении здоровых и необходимых, конституирующих и основополагающих аспектов, которые соответствуют потребностям развития и формируют специфическую структуру субъекта, его внутреннее наследие.

На теоретическом уровне комплексную и сбалансированную позицию, включающую различные потенциально позитивные (= необходимые) и негативные (= фиксирующие) аспекты слияния, выдвинул Пайн (Pine, 1990, р. 245), который в открытой формулировке охарактеризовал симбиотическую фазу как «критическое время для формирования тех моментов слияния (связанных с кормлением и засыпанием, когда младенец растворяется в теле матери), которые происходят в первые месяцы жизни».

Даже сегодня в некоторых клинических отчетах внимание уделяется не тому, что этот опыт слияния в свое время

не был полноценно пережит и поэтому способность должным образом его переживать во взрослом возрасте отсутствует; скорее, подчеркивается тот факт (который в большинстве случаев является очевидным следствием), что этот опыт ищут снова и безуспешно, с одержимой настойчивостью и способами, не соответствующими взрослому состоянию, как это часто проявляется — непреднамеренно — во многих тяжелых случаях психических расстройств.

На практике эта аномальная настойчивость в неуместном и тревожащем стремлении к слиянию иногда рассматривается в клинике скорее как проблема *сама по себе*, чем как признак лежащих в ее основе и существовавших ранее проблем, почти как если бы классическая психиатрическая феноменология брала верх над более комплексным психоаналитическим пониманием. Из-за этого возникают неблагоприятные ситуации, когда аналитик предполагает, что должен *заставить пациента понять* на логическом уровне Центрального Эго то, с чем ему следовало бы помочь пациенту вновь войти в контакт, прожить и хотя бы немного проработать репаративно на уровне переживания Селф.

В большинстве случаев подчеркивание нарушенного функционирования эго во время сессии лишь усиливает страх пациента перед самим собой и вызывает у него страх и гнев по отношению к терапевту, что ведет к последующему застреванию и дальнейшему нарушению работы эго, и так далее.

Поэтому в данной главе я хочу обратить внимание на реляционную *среду*¹⁸, в которой происходит большин-

18 В оригинале — *medium*. — Прим. пер.

Телесные обмены между внутренними мирами включают двунаправленные движения и переходы *изнутри наружу и извне внутрь*: эти взаимобмены могут быть питающими, эвакуационными, генитальными, они включают признание желания, потребности, функционального сопряжения на разных уровнях, оплодотворения, трансформации и так далее.

Этот витальный способ интимного взаимодействия продолжается на протяжении всего нашего существования, частично трансформируясь в повседневной жизни в постоянном скрытом и глубоко бессознательном поиске психических эквивалентов того, что было телесным на досимволических этапах развития; или наоборот, в попытке заменить недостающее (и в отношениях, и в чувстве селф) конкретными элементами в настоящем, в ходе внутреннего обмена с другим.

Психоанализ, помимо всего прочего, — это наука, которая изучает, истолковывает и порой использует эти процессы на интрапсихическом и интерпсихическом уровнях.

На самом деле люди всю свою жизнь ищут близости — более или менее конфликтным способом. Мы наблюдаем это в повседневном взаимодействии, слышим в текстах практически каждой песни, сталкиваемся с этим в драматической и напряженной форме в нашей клинической работе, когда потребности и защиты проявляются и постоянно конфронтируют друг с другом, колеблясь между открытостью и закрытостью, приближением и отдалением, контактом и отстранением.

Люди постоянно создают и разрушают *случайные микросимбиозы или слияния* — как правило, даже не подозревая об этом, — используя свои более или менее разви-

тые навыки для организации потенциала психического сопряжения на разных уровнях.

Как бы то ни было, им необходима некоторая доля совместно испытываемой близости, чтобы питать, насыщать кислородом и возрождать свой внутренний мир всё новыми способами; хотя часто они склонны сознательно отрицать эту потребность, особенно когда их структура защит направлена в сторону фантазий всемогущей самодостаточности, а также нарциссических антиобъектных внутренних установок (как это бывает, например, при анорексии или нарциссических расстройствах личности).

Естественное развитие обеспечивает наличие *проходов извне внутрь (и наоборот)*, образованных особыми тканями — *слизистыми оболочками*, функция которых — создавать промежуточную среду, в которой обмены могут происходить свободно, а вещества — без промедления переходить от одного субъекта к другому, при условии, что такой обмен желателен и принимается обеими сторонами.

Мой вклад в эту область состоял именно в выделении *психических эквивалентов этих межтелесных процессов* и их рассмотрении в контексте психоаналитического процесса, с неизбежными последствиями для теории техники.

Хочу обратить внимание: здесь мы оказываемся в контексте событий, которые выходят за пределы (хотя и важной) сферы привязанности, *поскольку речь идет именно об обменах внутренними содержаниями*.

Здоровая близость — это естественное измерение глубокого интерпсихического обмена в совместно проживаемой атмосфере, в которой каждый человек может

как избыток субъективности, наоборот, может искажать понимание реальности.

Тем не менее мы знаем, что аналитические отношения ни в коем случае не являются нормальными человеческими отношениями из-за регрессии переноса у пациента и в связи с нашими собственными терапевтическими полномочиями и ответственностью.

Наша способность симметрично со-испытывать субъективность пациента, разделять (где необходимо) его состояния селф, частично становясь на его место, требует от аналитика четкой и устойчивой асимметричной внутренней позиции, которая остается открытой как для согласия, так и для взаимодополняемости, чтобы пациент мог проявлять свои внутренние сценарии в безопасных и творческих отношениях. Точно так же мы в том числе обязаны учитывать и исследовать опасности ложной, сбивающей с толку или потенциально разрушительной близости.

Как бы то ни было, можно утверждать, что без кропотливо выстроенной адекватной интерпсихической близости реальные изменения едва ли возможны, и анализ рискует остаться исключительно интеллектуальным упражнением, действующим лишь когнитивную деятельность коры мозга.

Однако замечу, чтобы не возникло недопонимания: меня интересует интимность так же, как интересовали эмпатия и *rêverie*; но я критически отношусь к *интимизму*, так же критически, как относился к *эмпатизму* и как отношусь теперь к потенциальному «*реверизму*».

Это имитационные научные вырождения, и любая попытка преднамеренно и деятельно создавать близость

обречена на провал, точно так же, как это произошло с эмпатией и *rêverie*.

Можно сказать, что мы не способны *решить* быть близкими: всё, что нам остается, это согласиться начать предположительно длительное и технически сложное психическое сосуществование с как минимум проблемным собеседником, опираясь на нашу выработанную способность к интеграции (прежде всего на уровне нашего *Профессионального Селф*) и на научную компетентность (прежде всего на уровне *Профессионального Эго*), чтобы пройти этот путь.

Но мы также знаем, что, как и в любом путешествии, постоянное психическое сосуществование рано или поздно приведет нас к некой форме близости. Готовы ли мы и действительно ли открыты для этого утонченного приключения в отношениях, выходящих за рамки наших абстрактных и порой противоречивых идеалов?

В конечном счете, так же как эмпатия и *rêverie*, близость в анализе не может возникнуть по команде или по теоретическому указанию: обычно для этого требуется соблюсти ряд условий, которые кажутся простыми, но на самом деле весьма сложны, а также проделать совместную работу по созданию таких условий там, где они отсутствуют.

Кроме того, необходимо, чтобы хотя бы один из участников имел ранее непосредственный опыт интерпсихической близости в обычной жизни: теория мало что даст, если аналитик в личной жизни или в ходе профессиональной подготовки не испытал на себе в достаточной мере понимания, как и когда становится возможным переход чего-либо из внутреннего мира одного во внутренний мир другого.

Мортиция, зрительница собственного желания

Именно в такой ситуации я знакомлюсь с Мортицией, молодой женщиной, студенткой школы психотерапии. На первой сессии она долго рассказывает о стажировках, часах практики, которые нужно пройти для школы, о предыдущем опыте. Слушая ее, я задумываюсь, нужен ли ей терапевт или просто сертификат.

Я спрашиваю: «Вы действительно хотите заниматься психотерапией, или вы здесь потому, что это необходимо для учебы?» Предлагаю ей подумать об этом и даже подождать несколько месяцев, если нужно. Она уходит слегка разочарованной.

Вторая сессия начинается с того, что девушка внезапно задает почти провокационный вопрос: «Как можно быть уверенной, что собственный отец не домогался тебя в детстве?» Она произносит это с любопытством, без страха. Такое чувство, будто она хочет забросить приманку, чтобы посмотреть, как яотреагирую.

Боли нет, есть контроль. Пациентка, по всей видимости, стремится удерживать власть на аналитической сцене: привлекает внимание, интригует, но не раскрывается по-настоящему.

Я соглашаюсь взять ее в терапию, понимая, что нам с ней придется работать не на ментальном уровне, а на инстинктивном. Мортиция всегда опаздывает на десять минут. Это маленькая деталь, но она соответствует общей динамике: пациентка сама решает, когда приходить, сколько давать, сколько брать. Она всегда старается говорить какие-то правильные вещи

и изо всех сил пытается сама интерпретировать свое поведение.

Сон о трупе

Спустя несколько месяцев Мортиция рассказывает сон: «Я одета как девушка начала XX века, со мной в комнате молодой Леонардо Ди Каприо. У изножья кровати с балдахинном стоит гроб, в нем лежит красивая мертвая женщина. Я закрываю дверь и предлагаю Ди Каприо заняться с ней сексом. Он сначала колеблется, но потом соглашается. Сцена меняется: теперь мертвая женщина лежит на кровати в объятиях Леонардо Ди Каприо. Они вместе курят сигарету, как сообщники, а я смотрю на них со стороны».

Пациентка связывает этот сон с предыдущей сессией, на которой мы говорили о ее матери. Когда Мортиция была маленькой, ее мать после развода с отцом приводила домой слишком много мужчин, и это длилось годами. Таким образом, как мать она была мертва, убита самкой внутри нее, «или, возможно, моей детской злостью», как предполагает Мортиция.

В этих рассуждениях о жизни и смерти, вине и удовольствии, о мертвом первичном объекте, на мой взгляд, слишком много психоанализа и слишком мало живых эмоций.

Вскоре после этого Мортиция рассказывает, что недавно проверяла телефон своего парня, подозревая, что он скрывает что-то насчет своей бывшей девушки.

Речь идет о контроле и ревности, но не касается главной темы — секса, которая висит в воздухе невысказанной, и поэтому я спрашиваю напрямую:

где тревога рассеется, а переживания будут наделены аффективным значением.

Это подростки, прибегающие к суицидальным действиям, ограничивающие потребление пищи или проявляющие агрессию. Они словно бросают вызов жизни, которую не в силах выдерживать, находясь под властью «конкретного» мышления и зрительных, слуховых, проприоцептивных ощущений, которые пугают их так, словно они оказались в ловушке *телесного галлюциноза* (Bomba, 2023). Их дестабилизирует тело, переживаемое как чужое. Это состояние сопровождается тем, что можно описать как «конкретный язык», аффективно бедный и кажущийся пустым, негодным для осмысленной коммуникации. Именно эту особенность мы постараемся осветить в нашем клиническом описании после краткого общего введения.

Примитивная психическая организация и терапевтическая трансформация

Когда мы наблюдаем примитивное состояние психики, мысли и чувства пациента кажутся фрагментированными, словно кусочки замороженного сенсорно-психического пазла. Однако при эффективной терапии в условиях госпитализации пациенты как будто вновь оживляют свое тело — а вместе с ним и психику — и, подобно новорожденным, проявляют внимание и любопытство к ощущениям, возникающим внутри них в состоянии относительного спокойствия.

Эта трансформация нестабильна; скорее, пациенты колеблются между фрагментарными, сенсорными ре-

жими функционирования и переживаниями психосоматической интеграции. Речь не идет ни о новой линии развития, ни о полном излечении за время краткой госпитализации. Скорее, это колебание между психическими состояниями подобно двери, осторожно открывающейся навстречу новым возможностям роста. Это движение имеет клиническую ценность.

Клинический опыт показывает, что работа с такими пациентами требует развития семиотической чувствительности, клинической интуиции и бдительного прислушивания к их коммуникациям во всех формах. Интеграция психоаналитического слушания бессознательных коммуникаций с психиатрической практикой сделала такую работу возможной.

Это также позволило разработать особый подход к слушанию и лечению психических срывов у подростков. Этот способ работы с пациентами, страдающими от тяжелых острых расстройств психики, будет проиллюстрирован клиническим примером и концепцией «говорящих действий» Ракамье.

Роза

Роза — подросток, госпитализированный с тяжелой формой нервной анорексии. Крайне истощенную, ее забрали из дома и отвезли в больницу на скорой. Моя коллега, обнаружившая ее в таком состоянии накануне, организовала ее перевозку. Роза заперлась в спальне, которую делила с матерью и сестрой. Она лежала на кровати под грудой одеял и свитеров, в темной, грязной и небранной комнате. Тот факт, что психиатр специально пришла

В первые дни ее пребывания в отделении я заметила, что Роза ищет меня взглядом и несколько секунд смотрит на меня, чтобы убедить себя съесть немного больше, или поговорить со своим отцом, или согласиться на действия медсестер. Этот особенный зрительный контакт, казалось, был ключом к ней. Теперь мне было позволено войти в ее мир, который она выстраивала заново.

Когда Розе стало лучше, мы смогли приступить к первым психологическим сессиям. Она предпочитала лежать на кушетке и всегда приносила с собой светло-голубое одеяло, то самое, которым мы укутали ее в первый день.

В течение месяца в больнице Роза говорит о желании превратиться в жидкость, умереть, медленно растворяясь. Это затопляющее желание, которое она переживала в недели, проведенные взаперти с матерью и бабушкой, иногда возвращается и теперь, по вечерам, когда ей бывает одиноко. Она рассказывает о том дне, когда моя коллега пришла к ней домой и спасла ее: «Когда дверь открылась и весь этот свет хлынул внутрь, что-то произошло... Я поняла, что ей не всё равно».

Роза смогла дать жизни еще один шанс и приняла (и поняла) необходимость остаться в терапевтическом реабилитационном центре, не возвращаясь домой после выписки, пока ей не станет лучше. В один из последних дней она рассказала сон: *«Я в большом доме... стены окрашены в мягкие цвета, персиково-розовые... Я не одна, рядом со мной люди, и я участвую в общем проекте. Мы должны что-то построить, не знаю, что именно... Я знакомлюсь с человеком, должно быть, он руководит всем этим, потому что у него есть план проекта, чтобы направлять работу»*. Роза связывает этот сон с планом ее

лечения в терапевтическом реабилитационном центре и испытывает чувство безопасности в присутствии мужчины, который будет вести работу с ней и группой.

Результаты лечения Розы, которое началось в больнице и продолжалось в реабилитационном центре, а затем в течение пяти лет психоанализа, были весьма удовлетворительными.

Некоторые размышления *après coup*⁴¹

У психотических пациентов и нередко у пограничных слова не содержат никаких сообщений. Их смысловая пустота порождает скорее «мышление через действия», чем «мышление через мысли», и сами слова могут переживаться такими пациентами как потенциальный обман (Racamier, Taccani, 1999a).

По этой причине психотические пациенты часто ненавидят слова и, не в состоянии обходиться без них, стремятся их «расходовать» и истощать (Racamier, Taccani, 1999b).

При первой встрече в отделении кричащая и разъяренная Роза кажется облеченной в подобие *второй кожи*, способной звучать и защищающей ее от «бесформенного ужаса» (Ogden, 1989): она застревает на одном слове и повторяет его бесчисленное количество раз, словно пытаясь израсходовать все слова до конца. Крича и повторяя «хочу к маме», она, казалось, пыталась остановить мысли и прекратить чувствовать эмоции, стоящие за этой фра-

41 Последствие. Фрейд использовал термин *Nachträglichkeit* (нем.) (во французском *après-coup*, в итальянском *risignificazione*) для обозначения процесса, при котором эмоциональные события прошлого могут обрести новый смысл в свете текущего опыта. — Прим. ред.

даваемый и заново изобретаемый во взаимоотношениях с каждым пациентом (Ferro, Civitarese, 2015; Ogden, 2025), своего рода марионетка, которую в аналитической игре можно мучить, не понимать, оскорблять, не разрушая при этом самое приватное чувство «я» аналитика.

Мистер Хайд же, напротив, хранит наиболее деликатные и личные переживания «я»: пространство *rêverie*, собственное аналитическое функционирование, но также воспоминания о нежности и эмоциональные ассоциации, связанные с его носками. Это то пространство, которое мы ощущаем как «наше собственное», независимо от того, насколько оно трансформируется и деформируется встречами с другим в неизбежном эмоциональном и субъективном взаимопроникновении. Это место, где мы можем быть наедине с собой, даже в присутствии другого (Winnicott, 1958, 1971).

Глубинный смысл моего предупреждения заключается в необходимости оберегать наиболее приватные области нас самих, которые неуместно и не полезно разделять в открытую с конкретным пациентом, если мы хотим сохранить большую свободу в пространстве совместно проживаемого вымысла аналитической игры (Winnicott, 1965; Ogden, 2018b; Civitarese, 2021).

В отличие от нарративного пространства, несущего совместно создаваемую в сессии с пациентом истину, я предлагаю проявлять осторожность в раскрытии элементов жизни и приватных мыслей мистера Хайда, Луки или Джейн. Это пространство, оберегаемое сеттингом, тем более значимо, чем интенсивнее становятся отношения; пространство, имеющее отношение прежде всего к другим связям — с самим собой и с другими, — где персонаж покидает сцену, уступая место личности.

Пациенты жаждут живого присутствия аналитика, которое формируется в совместно проживаемом с ними опыте, а от прямолинейного, «сырого» рассказа они редко что-либо выигрывают. Личная биография вступает в сессию не как автобиографическая история, а как психический материал, который питает чувствительность, отзывчивость и способность осмыслять поле (Ogden, 1994; Civitarese, 2005; Ferro, 2009).

Самораскрытие зачастую мотивировано потребностью аналитика снизить эмоциональное и переносное напряжение в работе с пациентами, и разделение собственных переживаний становится легким способом расслабиться (Freud, 1912; Jacobs, 1999).

Кроме того, мы не можем знать, как пациенты будут употреблять (и злоупотреблять ими) эти ценные фрагменты нас самих в последующие месяцы или годы, и сколько страдания это может нам причинить; поэтому разумно сохранять их в безопасном месте.

Наконец, следует помнить, что любая откровенность необратима, так что мы никогда больше не сможем работать с пациентом, который не знает этой стороны нас.

Итак, как нам тогда начинать сессию по-новому, не подвергая себя излишним рискам?

Ненасыщенные реакции и ирония: инструменты аналитического поля

Наряду с классическими вариантами, не утратившими своей ценности, сегодня, когда молчание кажется не лучшим выбором, я предлагаю использовать ненасыщенные, ироничные реакции, способные передавать аффект и ле-

Есть моменты в этой жизни, которые делят ее на «до» и «после». И, похоже, это знакомо каждому из нас. Вы можете вписать туда любое событие, которое провело черту где-то глубоко внутри вас. Подумайте о чем-то, после чего вы уже не были прежним.

Продолжали ли вы работать?

«Здравствуйте! У меня, к сожалению, сегодня чрезвычайные обстоятельства, в связи с которыми не смогу провести сессию, поэтому вынуждена ее отменить. Буду ждать вас в следующий раз по расписанию», — утром я отправляю два таких сообщения клиентам, сессии с которыми назначены на 13 июня.

Мне везет. Если, конечно, можно так сказать в сложившихся обстоятельствах. Первые три дня войны у меня нет ни групп, ни клиентов. Работаю я по расписанию российского, и на эти даты выпадают праздники. Так моя русская идентичность спасает израильскую.

Что я не смогу работать в это время, мне становится кристально понятно утром 13 июня, когда я отменяю эти две сессии. Состояние неопределенности, депривация сна, постоянно срабатывающие воздушные тревоги.

Есть опыт, о котором лучше прочесть в книгах. Теоретизировать. Размышлять на супервизиях. Шерстить по справочникам. Умными словами говорить о «симптомах» и «проявлениях».

За первые три дня я приобретаю опыт переживания острого стрессового расстройства. Не теоретический. Эмоциональный. И иногда, сидя в миклате⁴³, вздрагивая

от грохота из-за вылета ракет-перехватчиков, я вспоминаю Биона и его «мыслить под обстрелом».

Задача, красиво звучащая теоретически. И невыносимая, когда становится буквальной.

Но мы попытались.

И даже на любой из других планет
Я найду тебя сквозь миллионы лет,
А у тебя всё так же горит свет,
И если ты со мной, то значит, смерти нет.

Люди, с которыми я работаю, находятся в другой реальности. И каждому из них, будь то индивидуальный клиент или группа, мне теперь необходимо рассказать о своей. Потому что теперь моя реальность не мифическая. Она не остается за пределами нашего виртуального кабинета, а буквально становится его частью.

Каждый раз, когда срабатывает сигнал тревоги и я вынуждена прервать сессию. Каждый раз, когда кто-то из клиентов читает новость о попадании ракеты в Тель-Авив. Хайфу. Беэр-Шеву. Каждый раз, когда в начале сессии от клиента звучит вопрос «как вы». И на него нельзя ответить в рамках психоаналитической техники: «похоже, вам тяжело начать говорить о себе» или «у вас есть какие-то фантазии о том, что со мной происходит?». Потому что единственно верный ответ в этой ситуации, на мой взгляд, человеческий.

И со временем он начинает звучать, возможно, по мнению многих коллег, совсем не аналитично. Но очень искренне:

— Лучше, чем вчера.

того, чтобы пациенты и в отсутствие стен (безопасности онлайн-сессий) сохраняли место в психике аналитика.

Когда аналитик способен удерживать аналитическую позицию, опираясь в том числе на помощь своих пациентов, последние могут ощущать себя контейнированными даже вне встреч. Как подчеркивает Эмануэль Берман (Berman, 1999), «аналитик больше не может делать вид, что находится за пределами истории, он должен взять на себя ответственность за то, чтобы быть в ней вместе с пациентом».

С этой точки зрения, аналитическая близость, сложившаяся между Полиной и ее пациентами, порождает защищенное пространство отношений (Nicolì, 2023a), где два уязвимых субъекта продолжают мыслить, даже под бомбами.

Заключение

Полина Черкас, подобно Кляйн и Винникотту до нее, работает во время бомбардировок. Однако ее аналитическая работа происходит в эпоху онлайн, в условиях, когда война присутствует во всех медиа и когда реальность буквально вторгается в аналитическое пространство.

Ее опыт заставляет задуматься, что значит быть аналитиком во времена, когда миф о профессиональной невзможности начинает трещать по швам.

Может быть, уязвимость, которая отнюдь не является слабостью, представляет собой наиболее подлинную форму аналитического присутствия: мыслящую рану, способную трансформировать страх в совместное мышление и сно-видение, даже когда мир вокруг, кажется, рушится.

Рождение дочери как «переломный» момент: непрерывность и катастрофические изменения в идентичности аналитика-отца

Лука Николи

Великая жертва аналитика

В этой небольшой работе я намереваюсь исследовать взаимосвязь между аналитической семьей (Bolognini, 2004, 2008a) и семьей биологической в момент появления ребенка на свет. Это событие либо приводит к неизбежному перелому в прежней структуре идентичности, либо, наоборот, выявляет непроницаемость селф для новых функций, находящихся в процессе становления.

Каждый специалист постоянно балансирует между профессиональной и семейной идентичностью. Особен-

с течением времени. Уже в мифе о Кроносе отец остается всемогущим до тех пор, пока обладает жестокой способностью пожирать своих детей: это воплощение отрицания времени. Миф о Кроносе — это не только символ, он олицетворяет опасность психически парализованного мужского начала, отца, неспособного порождать, не контролируя или не разрушая. Аналитик, подобно мифологическому Кроносу, может оказаться заключенным в ловушку восприятия вневременной вечности, приговоренным к всемогуществу (Bion, 1978; Loewald, 1979/1980; Ogden, 2006).

На ум приходят мифические образы аналитиков, принимающих пациентов на рассвете; супервизоров, работающих по воскресеньям, а также табуированная тема ухода на пенсию, недавно затронутая в книге *The Empty Couch* (Junker, 2013). Многие встречи между коллегами начинаются с вопроса «Как дела?», за которым неизбежно следует: «Ну, я немного устал...»

Аналитик черпает определенное удовлетворение, ощущая себя вне биологической и социальной истории, заново создаваемым пациентами в роли то отца, то сына, то возлюбленного (Ogden, 2007; Bromberg, 2001). Такое отношение можно понять как защиту от мимолетности эго: поддержание иллюзии абсолютного контроля и постоянства гарантирует нарциссическую непрерывность, хотя и снижает гибкость и способность интегрировать непредвиденные жизненные события, такие как рождение ребенка (Winnicott, 1965; Civitarese, 2010).

Институциональные рамки усиливают эту ригидность: коллективное супер-эго обеспечивает чувство безопасности, но вместе с тем может приводить к затвер-

деванию внутренних моделей и торможению развития аналитической идентичности, вплоть до утраты контакта с естественным течением жизни (Civitaresse, 2016; Ferro, Nicoli, 2023).

Чтобы стать отцом...

Рождение ребенка представляет собой «катастрофическое изменение» в жизни аналитика, то есть событие, которое резко нарушает психическое равновесие и требует реорганизации психических функций для ассимиляции опыта (Bion, 1965). Оно способно поколебать структуру идентичности и подвергнуть испытанию на прочность внутреннюю родительскую функцию (Winnicott, 1960; Bion, 1962). Это не просто изменения в логистике или в распорядке дня: устойчивые аффективные конфигурации и идентификации оказываются в кризисе. Аналитика, как и любому другому новоиспеченному родителю, приходится заново определять приоритеты, принимать на себя новые формы ответственности и сталкиваться с неопределенностью и уязвимостью, которые возникают в отношениях с ребенком (Ferro, Civitaresse, 2015).

«Сколько сессий в неделю заслуживает мой ребенок? Смогу ли я сохранить то же внимание, которое уделял курсу наблюдения за младенцами⁴⁵? Насколько эмоционально тяжелым становится конфликт между аналитической практикой и семейной жизнью, если я измотан после девяти часов работы?» Интеграция профессиональной и отцовской идентичностей вовсе не является чем-то

45 Курс наблюдения за младенцами является обязательным при подготовке детского психоаналитика. — *Прим. пер.*